



סכמת טיפול - פצוע בודד

X-CARE vs PHTLS

תמונות מעובדות באמצעות AI ומקורן ממצגת של TCCC



מטרות המצגת

- מיקוד החניך על השינויים בסכמה האחודה למטפל מיומן בצה"ל
- פירוט התיאורים הכלליים שמאחורי הבדיקות אשר מפורטות בסכמה החדשה.
- הטמעה של הסכמה החדשה בקרב המטפלים המיומנים בצה"ל.

הסכמה האחדה לטיפול בפצוע בודד

X-CARE

צוות מועדף
לביצוע השלם

30 שניות

60 שניות

פינוי

30 שניות

60 שניות

תחילת פינוי בהתאם למצב המצוי. יוכלת הטיפול בפניו
יחולק הפינוי יש לבצע חיתוך מצב צוואר ולהעביר דיווח רפואי
השלמת השלבים הבאים במהלך הפינוי

סקר שניוני

מה עומד

זוהר אל

X

EXtract

C

Circulation

A

Airway

R

Respiration

E

& Exposure
Evacuation

ביצוע תרגולת 'חלץ-טפל' או טכניקה קרבית "פצוע בכוח":

- הכרה בשטח ובקשר על פצוע בכוח
- השגת עליונות באש
- הגעה למחסה ראשוני ע"י חילוץ עצמי או על ידי כוח שהוגדר לכך
- עצירת דימום פורץ עצמאית או ע"י לוחם/מטפל סמוך

- הגעה לסביבה מאובטחת/בטוחה
- התרשמות ראשונית מהירה - מנגנון הפגיעה, בחינה ויזואלית ופניה לפצוע, דחיפות
- דיווח אגמי - פניה, הודעות, תיאור האירוע, מיקום, מספר פצועים ודחיפות פנימי

- עצירת דימום פורץ. במידה ובוצע בדרג קודם - יודא שהדימום נעצר
- חיפוש אחר פציעות ומקורות דימום בגוף, בגפיים ובאזורים נסתרים
- תוך ביצוע הפיכה והפשטה - ראש, חזה, עורף, בתי שחי, גב, גפיים, עכוז ומפשעות - עצירת דימום שזוהה

הערכה קלינית:

- בדיקת הכרה לפי AVPU
- בהיעדר נשימה או בהיעדר תגובה לכאב - ביצוע JT והחדרת AW
- בטראומה ישירה לנתיב האוויר - סילוק הפרשות והושבה
- מדית לחץ דם
- מדית דופק איכותית וכמותית
- מדית ריווי חמצן (סטורציה)

- בהלם עמוק על פי הקריטריונים - הנחיית הצוות להשגת גישה למחזור הדם והכנת מוצרי דם
- המשך ביצוע הסכמה על ידי מט"ב
- הפעולות עצמן יבוצעו על ידי חובשים בלבד בשלב זה

- הערכת נתיב האוויר ומצוקה נשימתית תוך פניה לפצוע והסתכלות. שימוש באמצעים בסיסיים לניהול נתיב האוויר.
- פתירת פה וסילוק הפרשות
- הושבה
- העשרה בחמצן
- בהיעדר נשימה - הנשמה באמצעות אמבו ומסיכה
- בחדש לפגיעה - שמירה על עמש"צ
- חשיפת בית החזה והתרשמות מסימני חבלה

- יודא הפשטה מלאה והפיכה - איתור כלל הפציעות, עצירת דימום במידה זוהה
- ראש - התרשמות מסימני חבלה
- עמש"צ - בחשד לפגיעה - הנחת צווארון
- אגן - הערכה וביצוע כריכת אגן
- כיסוי, חימום והעמסת לאלונקה
- חיתוך מצב - סיכום הממצאים, הגדרת דחיפות הפינוי ומתן הנחיות לצוות
- העברת דיווח רפואי והשלמת תיעוד ב-101 דיגיטלי או דיני

זוהר אל

C

A

R

E

Everything
Else

טיפול מתמשך
PFC
Prolonged
Field Care

- הערכת הלם חוזרת והמשך החזר נפח לפצועים בהלם עמוק
- השגת גישה למחזור הדם וקביע
- מתן TXA
- הערכה חוזרת והמרת חסמי עורקים
- קביע ומתיחה של שבר בירך באמצעות סד תומאס
- השלמת עירוי פריפרי שני בפצוע שנוקק להחזר נפח

- הערכה חוזרת של נתיב אוויר וניהול שמרני או ע"י התערבות

- העשרה בחמצן
- בפצוע מונשם חיסור למנשם והכנת תרופות הרדמה להמשך
- החדרת נקז חזה לפצוע חזה מונשם במידת הצורך בלבד

- הערכת כאב וטיפול
- מניעת זיהומים - שטיפת פצעים, חבישה, טיפול אנטיביוטי
- הערכת GCS, התרשמות מתנועות ידיים ורגליים ובדיקת אישונים
- סריקה גופנית מלאה מהקודקוד ועד לבהונות הרגליים - טיפול בכל פציעה המזהה בדרך
- קביע שברים
- יודא כלל הקיבועים
- השלמת תיעוד ב-101 דיגיטלי או דיני
- הערכה לקימה של תגובת דחף/קרב וביצוע התערבות יחל"ם
- העברת דיווח רפואי חוזר

- ניטור ותיעוד הסימנים החיוניים באופן תדיר ומחזורי
- החדרת נקז חזה לפצוע חזה נושם עצמונית עם הדרדרות נשימתית
- מתן חוזר של טיפול תרופתי תוך ורידי
- הכנסת צנתר שנתן ובפצוע מונשם הכנסת אונדה לניקוז הקיבה
- מניעת פצעי לחץ

בעבודה בצוות יש חשיבות רבה לביצוע שליבי הסכמה במקביל, בדגש על הערכה המודינמית ומתן של מוצרי דם

יבוצע בטכנות מט"ב בלבד
יבוצע בטכנות התוויה בלבד, ראה פרק מתאים

דוגמא לביצוע של הסכמה בעבודת צוות

מט"ב	חובש 1	חובש 2
- התרשמות ראשונית מהירה - עצירת דימום פורץ - חיפוש מקורות דימום סלל הפיכה - הערכה קלינית של הפצוע (AVPU), קצת נשימה, טראומה לעי באוויר, דופק וסטורציה (לד) - הערכת הלם עמוק והחלטה על מתן מוצרי דם - הערכת AW ומצב נשימה - בחדש לעיכה - ניהול AW בסיסי - ביעדר נשימה - הנשמה באמבו ומסיכה - שמירה על עמש"צ	- יודא אגמי ודחיפות פנימי - מדית לד - פאלס על האבצ - דופק וסטורציה - בחדש נשימה - הנשמה באמבו ומסיכה - בהלם עמוק - השגת גישה למחזור הדם ומתן מוצרי דם - דיווח רפואי (טורם התחלת פינוי) - חמצן במידת הצורך - העברת דיווח רפואי עדכני	- הגעה לסביבה מאובטחת - יעצירת דימום פורץ - חיפוש מקורות דימום סלל הפיכה - הפשטה מלאה כולל איזור מעבר - ביצוע כריכת אגן במידת הצורך - כיסוי, חימום והעמסת וקביע על אלווקה - השלמת תיעוד ב-101

התחלת פינוי במידה חסר - חיתוך מצב ודיווח

חשיפת ביהח"ז, התרשמות

הפשטה מלאה כולל איזור מעבר

ראש - התרשמות מתחלת

עמש"צ - החת צווארון בחשד לעיכה

הערכת אגן והחלטה על כריכה

כיסוי ואלוקה

סיכום הממצאים - הגדרת דחיפות ותכנית טיפול



הגדרות בסכמה החדשה

- **שינוי:** הסכמה נכתבה לא לחובש / מט"ב אלה לחוליה רפואית שלמה.
- בסכמה הנחת היסוד היא שניתן לחלק משימות ודברים יבוצעו במקביל.

בעבודה בצוות יש חשיבות רבה לביצוע שלבי הסכמה במקביל, בדגש על הערכה המודינמית ומתן של מוצרי דם 

- **שינוי:** בסכמה מוגדרות פעולות שיבוצעו בנוכחות מט"ב בלבד

 יבוצע בנוכחות מט"ב בלבד

 יבוצע בנוכחות התוויה בלבד, ראה פרק מתאים

- בסכמה יש סימונים שמפנים לאגרות.

- הסכמה החדשה מתבססת על הנחת היסוד כי רוב מוחלט של פצועים שדורשים התערבות מיידית סובלים מדימום, וזקוקים להחזר נפח ופינוי דחוף.



- הסכמה לא נותנת מענה לחולים, אלא לפצועים בלבד.

- בסכמה החדשה שינו את האותיות.

- לסכמה צמצמו את שלב ה Safety הכללי, לשלב חילוץ מ"מתאר תחת אש".



שלושת מתארי הטיפול ב TCCC

- גישה לפצוע בעת לחימה שונה במתארים השונים:
- **מתאר "תחת אש"**
- "עליונות אש היא התרופה הטובה ביותר"
- "חיי הפצוע הראשון מונחים בידי הראשון שמניח את התחבושת"
- **מתאר "מאויים-מאובטח"**
- **מתאר "הפינוי הטקטי"**





סכמת X-CARE





שלב ה - X

ביצוע תרגולת 'חלץ-טפל' או טכניקה קרבית "פצוע בכוח": **2**

- הכרזה בשטח ובקשר על פצוע בכוח
- השגת עליונות באש
- הגעה למחסה ראשוני ע"י חילוץ עצמי או על ידי כוח שהוגדר לכך
- **עצירת דימום פורץ** עצמאית או ע"י לוחם/מטפל סמוך

- הסכמה מתחילה כאשר יש פצוע ב"מתאר תחת אש".
- השב באש ותפוס מחסה.
- פכט"ת (פניה, כיוון, טווח, תיאור).
- "חלץ טפל!" (השג עליונות אש וחלץ פצוע במידה ולא מחלץ עצמאית).
- אחרי הגעת הפצוע למחסה עודד פצוע לעצור דימומים מסכני חיים בכוחות עצמו.
- עצור דימומים מסכני חיים במידה והפצוע מתקשה.
- קדם את הפצוע ל"מתאר מאוים-מאובטח".





שיטות לניוד פצוע

גרירת יחיד



גרירה בזוג



מהיר
טווח קצר



הובלה בזוג



ג'יפ



הובלת יחיד



אחד על אחד

איטי
טווח ארוך





שלב ה - X

- הגעה לסביבה מאובטחת/בטוחה
- התרשמות ראשונית מהירה - מנגנון הפציעה, בחינה ויזואלית ופניה לפצוע, דחיפות
- דיווח אגמי - פניה, הזדהות, תיאור האירוע, מיקום, מספר פצועים ודחיפות פינוי

- סביבה מאובטחת = "מתאר מאוים-מאובטח".
- סביבה בטוחה = אחרי "מתאר פינוי טקטי", כלומר 0 איום.



מקום בו בטוח מספיק לבצע הפשטה הוא לכל הפחות "מתאר מאוים-מאובטח"

- הגדרה של פצוע דחוף:

CAT, סכנה לגפה או איבר,
רסיס מבודד בראש / גו / אזור חיץ, ירידה
ברמת הכרה



שלב ה - C

- **עצירת דימום פורץ.** במידה ובוצע בדרג קודם ← וידוא שהדימום נעצר
- **חיפוש אחר פציעות ומקורות דימום** בגו, בגפיים ובאזורים נסתרים תוך ביצוע הפיכה והפשטה - ראש, חזה, עורף, **בתי שחי**, גב, גפיים, עכוז ומפשעות - עצירת דימום שזוהה

חידוש:

- הפשטה והפיכה כבר בשלב הזה.
- חיפוש אחר דימומים מסכני חיים גם באזורי חיץ כבר בשלב הזה.
- "דימום פורץ" – נשאר. שוב יוצאים מנקודת הנחה שחובש/מט"ב מבינים אינטואיטיבית מה זה אומר.
- תזכורת: נאמר "דימום מסכן חיים".



קטיעה



בגד ספוג בדם,
שלולית דם מרשימה



דם יוצא בכמות מרשימה
(משפריץ או נוזל)



שלב ה - C

הערכה קלינית:

- בדיקת הכרה לפי AVPU
- בהיעדר נשימה או בהיעדר תגובה לכאב ← ביצוע JT והחדרת AW
- בטראומה ישירה לנתיב האוויר ← סילוק הפרשות והושבה
- מדידת לחץ דם
- מדידת דופק איכותית וכמותית
- מדידת ריווי חמצן (סטורציה)

● לא מגיב לכאב = מחוסר הכרה

● שינוי: פגיעות נתיב אוויר ספציפיות:

- שבר לסת עליונה עם תזוזה משמעותית שתחסום את הנזופרינקס
- גופים זרים לרבות שיניים שבורות או שברי עצמות
- שבר לסת תחתונה קדמי דו-צדדי שתגרום לצניחת לשון
- טראומה ישירה ללרינקס או לקנה

● מדידת לחץ דם תתבצע בנוכחות מט"ב בלבד

● שינוי: במידה ולא מתקבלת קריאה במד לחץ הדם או במד סטורציה

● מדידת דופק איכותי וכמותי מד סטורציה רדיאלי קרוטידי

6

התוויות

15 שני



6 סיבות להתערב בנ"א

בשלב ה - C



• מי מקבל מנתב אוויר?

• מחוסר הכרה

• לא נושם

• מי מקבל סילוק הפרשות והושבה?

• שביר לסת (עליונה עם תזוזה, תחתונה דו-צדדי)

• גופים זרים

• פגיעה ישירה לנתיב אוויר, לרינקס או קנה



שלב ה - C

○ **בהלם עמוק על פי הקריטריונים ← הנחיית הצוות להשגת**



גישה למחזור הדם והכנת מוצרי דם

המשך ביצוע הסכמה על ידי מט"ב

הפעולות עצמן יבוצעו על ידי חובשים בלבד בשלב זה

שינוי:

- בסיום השלב הזה יש מספיק נתונים על מנת לזהות הלם עמוק.
- יש לשקול את תנאי הפינוי ובמידה קיים צורך וגם ולא ניתן יהיה להשיג גישה ורידית במהלך פינוי, ניתן לעכב פינוי לצורך השגת גישה (גרמית/ורידית).
- במידה וניתן להתחיל פינוי של פצוע בהלם עמוק, יש לעשות זאת כבר בסיום השלב הזה.
- השגת גישה ורידית לא תבוצע ע"י המט"ב.

האם הפצוע בהלם עמוק?

ל"ד סיסטולי נמוך מ 90 מ"מ"כ

או

ל"ד שאינו ניתן למדידה

וגם

היעדר דופק רדיאלי

או

שינוי ברמת הכרה

(שאינו על רקע חבלת ראש או תרופות)



סבב ראשוני?

כמו ב PHTLS



שלב ה - AR

○ הערכת נתיב האוויר ומצוקה נשימתית תוך פניה לפצוע והסתכלות.

ללא שינוי

- פניה לפצוע
- פתיחת פה, סריקת פה וסילוק הפרשות במידת הצורך
- האזנה לקולות נשימה חריגים מהפה
- שלמות לסת והמטומה בצוואר
- שיפור תנוחה במידת הצורך

○ שימוש באמצעים בסיסיים לניהול נתיב האוויר: **4**

○ פתיחת פה וסילוק הפרשות

○ הושבה

○ העשרה בחמצן **5**

○ בהיעדר נשימה ← הנשמה באמצעות אמבו ומסיכה

● **שינוי:** אין סיוע נשימתי עם מפוח למטופל נושם ברמת חובש.



שלב ה - AR

○ בחשד לפגיעה ← שמירה על עמש"צ

- בשלב הזה מדובר על קיבוע ממשוך ידני עד הנחת צווארון לפחות.
- במידה וקיים צורך לאבטח נתיב אוויר, יש לבצע JT.
- חשוב לזכור שצווארון מונע רק את התנועה "כן" של הראש, אך ללא קיבוע של רגליים, אגן וכתפיים לאלונקה קיבוע הצוואר למניעת התנועה "לא" יותר מזיק ממועיל.
- למרות זאת, אם ניתן לקבע באופן איכותי ומלא ויש התוויה, יש לעשות זאת.



שלב ה- AR

○ חשיפת בית החזה והתרשמות מסימני חבלה

ללא שינוי

- חשיפת בית חזה
- סריקת עצמות בריח ובית שחי
- במידה ולא ניתן להפשיט סרוק במישוש
- כולל גב
- הערכת קצב נשימה (0-10 , 10-20 , 20-30 , $30 <$)
- התרשמות מעומק נשימות
- סימני מצוקה נשימתית
- שימוש בשרירי עזר
- יחס שאיפה / נשיפה
- רטרקציות

30 שני'



שלב ה - E

○ וידוא הפשטה מלאה והפיכה -איתור כלל הפציעות, עצירת דימום במידה וזוהה

ללא שינוי

- חיפוש שט"דים מסכני חיים ועצירתם
- עצירת שט"דים מסכני חיים בלבד
- מילוי קפילרי
- מצב עור (טמפ', צבע, לחות)
- בטן וקפלי עור (שק אשכים, עכוז, כרס)
- בדיקת אגן וירכיים לרגישות, נוקשות ואסימטריה
- קיבוע במידת הצורך



שלב ה - E

○ ראש - התרשמות מסימני חבלה 

- סריקת ראש (יד דרך שיער, אוזניים ומאחוריהן, ערובות העיניים)
- שינוי: אין בדיקת אישונים



שלב ה - E

○ עמש"צ - בחשד לפגיעה ← הנחת צווארון  

- בנק' הזמן הזו, במידה וזוהתה התוויה לקיבוע עמש"צ ובוצע עד כה ביצוע ידני, יונח צווארון.
- בקש מהפצוע להניע כל גפה בנפרד.

○ אגן - הערכה וביצוע כריכת אגן  

- **שינוי:** קיבוע אגן עבר משלב C ראשוני לשלב הזה. אין הבדל טיפולי למעט שינוי באות.



שלב ה - E

○ כיסוי, חימום והעמסת לאלונקה

- סוף סבב ראשוני. כמו קודם.
- חשוב: לא כיסוי אלא עטיפה. במידה ומתאפשר, להקדים ביצוע.

60 שניות	30 שניות	60 שניות	30 שניות
תחילת פינוי בהתאם למצב המבצעי ויכולת הטיפול בפינוי ○ טרם הפינוי יש לבצע חיתוך מצב בצוות ולהעביר דיווח רפואי ○ השלמת השלבים הבאים במהלך הפינוי			עצרת סיום פינוי

- הסכמה מניחה שמסיום שלב חילוץ עד סיום סבב ראשוני יעברו כ 3 דק'.

- למעשה אם נתחיל פינוי לפני השלמת הסכמה המטופל מופשט ולא מכוסה עד שהמטפל המקבל לא יגיע לסוף סבב ראשוני – פוטנציאל להיפטרמיה.



שלב ה - E

- חיתוך מצב - סיכום הממצאים, הגדרת דחיפות הפינוי **ומתן הנחיות לצוות**
- **העברת דיווח רפואי** והשלמת תיעוד ב-101 דיגיטלי או ידני

● אין שינוי



שאלות עד כאן?

• סיכום הבדלים:

- שלב ה - X כולו חדש
- בשלב ה C המקדים, בדיקות C מבוצעות לפני בדיקות A ו B.
- בשלב ה - C המקדים, התערבות מינימאלית בבעיות A ו B, מיקוד בבעיות C, ובמידת האפשר תחילת פינוי.
- לחץ דם נמדד רק בנוכחות מט"ב, לראשונה בשלב ה C המקדים.
- גישה ורידית לא ע"י המט"ב.
- 6 התוויות בלבד להתערבות בנתיב אוויר ב C.
- יש אפשרות להתחיל פינוי בסיום C, לפני ARE.
- יש אפשרות לעכב פינוי לצורך השגת גישה ורידית (בהתוויה לוגיסטית).
- בדיקות והתערבויות בשלבי ARE זהות לבדיקות ב ABCDE.
- אין בדיקת אישונים יותר בצה"ל.
- אין יותר סיוע נשימתי במפוח למטופל נושם.
- יש מספר דברים שהיו רשומים באותיות אחרות ועכשיו הם ב E.



• X – טיפול בפצוע במתאר "תחת אש"

חיפוש ועצירת דימומים מסכני חיים (כולל הפיכה והפשטה ככל האפשר)
סטוראציה -> רדיאלי -> קרוטידי

C

סילוק הפרשות
ושיפור תנוחה

AVPU מחוסר -> AW

פתיחת פה, סריקת פה, קולות נשימה, שלמות לסתות, שלמות קנה

A

• C

לא נושם -> AW

נושם / לא נושם (בזמן בד' קולות נשימה)

B

לקבל נתון מהמד סטוראציה
להחליט אם הפצוע בהלם עמוק

אם פינוי, שוקלים השגת גישה ורידית לפני ואז SABCDE מלא בתחילת פינוי
אם לא BCDE

• A

• R

• E



התוויות התייחסות ניהול נתיב אוויר בשלב ה C:

- 1 **שבר לסת עליונה** עם תזוזה משמעותית שתחסום את הנזופרינקס
- 2 **גופים זרים** לרבות שיניים שבורות או שברי עצמות
- 3 **שבר לסת תחתונה קדמי דו-צדדי**
- 4 **טראומה ישירה ללרינקס או לקנה**
- 5 **חוסר הכרה**
- 6 **דום נשימה**

האם הפצוע בהלם עמוק?

ל"ד סיסטולי נמוך מ 90 מ"מ"ב

או

ל"ד שאינו ניתן למדידה

וגם

היעדר דופק ריאלי

או

שינוי ברמת הכרה

(שאינו על רקע חבלת ראש או תרופות)

סבב ראשוני

במתאר "תחת-אש"

X

במתאר "מאויים-מאובטח"

C

הגדר הלם עמוק

AR

E

השבר באש ותפוס מחסה

פכט"ת

"חלץ טפיל" (השג עליונות אש וחלץ פצוע במידה ולא מחלץ עצמאית)

אחר הגעת הפצוע למחסה עודד פצוע לעצור דימומים מסכני חיים (עצור דימומים מסכני חיים במידה והפצוע מתקשה)

דיווח 5 המ' (מתי, מיקום, מנגנון, מספר פצועים, מצבם)

קדם את הפצוע למתאר מאויים-מאובטח

הפשטה והפיכה (חובש לבד חשיפה מהירה חלקית)

עצירת לשט"דים מסכני חיים מידית (נקודת לחיצה, פאקינג וח"ע)

בדיקת הכוה - AVPU

בדיקת נתיב אוויר - פתיחת פה, סריקת פה, סילוק הפרשות

בדיקת קולות נשימה מהפה כולל הערכת נשימה (נחירות, חרחורים, צרידות/סטרידור, דום נשימה, קולות תקינים)

בדיקת שלמות פנים (שבר לסת עליונה עם תזוזה משמעותית, שבר לסת תחתונה קדמי דו-צדדי)

בדיקת שלמות צוואר קדמי (טראומה ישירה ללרינקס או לקנה)

בחדש לפגיעת עמ"ש - קיבוע ידני עד השלמת קיבוע מלא

מידת לחץ דם מד סטורציה (להתרשמות מדופק) ● דופק ריאלי (איכותי) ● דופק קרטידי (איכותי)

הגדר האם קיים הלם עמוק

במידה ואפשר להתחיל פיני בלי לפטוע במתן נפח, החל פיני (דם מלא ● פלזמה ● הרטמן)

במידה ואי אפשר להתחיל מתן נפח במהלך הפיני השג גישה והכן נפח לפי תחילת פיני

● חובש במרחק יותר מ 15 דק' ממוצר דם ייתן הרטמן עד השגת דופק ריאלי

● אם A כבר בוצע אין צורך, אם לא, או בוצע לפני יותר ממספר שניות יש לבצע מחדש כמו שרשום ב C

חשיפת בית חזה

בדיקת קליקולות (מישוש וניקוש)

איתור פציעות בקידמת בית חזה (סרוק במישוש מגרפה / כפפה רטובה)

איתור פציעות בבתי שחי (סרוק במישוש מגרפה / כפפה רטובה)

מידת נשימות 30 שניות (0-10, 10-20, 20-30, >30)

התרשמות ממאמץ נשימתי

● יחס שאיפה / נשיפה (נשימה יותר ארוכה / שאיפה יותר ארוכה)

● רטרקציות

● שימוש בשרידי עור

סטורציה (איכות חמצון) אם לא נבדק

בדיקת בטן (סרוק במישוש מגרפה/כפפה רטובה ולחיצות לפי רבעים)

מידת דופק 15 שניות (כמותי - איפה שהיה דופק ב C)

מידת לחץ דם ● מילוי קפילארי + צבע עור הטהה טמפרטורה

יציבות אגן (ניקוש)

מפשעה ואיתור חיץ קידמיים (סרוק במישוש מגרפה / כפפה רטובה)

סחיטת יריכיים (דפורמציה / דימום פנימי)

הפיכה וסריקה לאיתור פציעות מקו שיער עד נעליים (סרוק במישוש מגרפה / כפפה רטובה)

בדיקת גפיים (תחושה / תזוזה / שלמות צורה)

שלילת עיניי דביבון

שלילת הפרשת CSF / דם מהאוזניים

שלילת סימני קרב

● אישושים (מורחבים / שווים / לא שווים / צרים)

איתור דימומים ודפורמציות (יד דרך שיער)

השלמת הפשטה

העלאה על אלונקה (מבנה - בד, חוץ - קשיחה)

עטיפה בשמיכת מילוט

סריקות ושימוש בתיק חפצים

דיווח מאסט (מנגנון, איתור פציעה, סימנים ותסמינים, טיפולים שבוצעו)

השלמת 101



סבב שניוני





שלב ה - C

- הערכת הלים חוזרת והמשך החזר נפח לפצועים בהלים עמוק **3**
- השגת גישה למחזור הדם וקיבוע **10**
- מתן TXA **3**
- **הערכה חוזרת והמרת חסמי עורקים**
- קיבוע ומתיחה של שבר בירך באמצעות סד תומאס **12**
- השלמת עירווי פריפרי שני בפצוע שנזקק להחזר נפח

שינוי:

- C לפני A
- מתן מוצרי דם כבר החל בסבב הראשוני
- חובש שנמצא מעל 15 דק, ממת"ב עם מוצרי דם, ייתן קריסטלואידים (הרטמן)



התוויות להמרת חסם עורקים

- מט"ב עד 6 שעות, חובש עד שעתיים
- אפשר להמיר לפאקינג / קטטר / פירסטקייר
 - יש לבצע לפני שחרור הקאט
- תנאיי חובה:
 - לחץ דם סיסטולי מעל 90 ממ"כ
 - דופק איטי מ 110 פעימות לדקה
 - קיימת גישה ורידית
- יש להקפיד על השגחה למשך 5 דקות ברציפות לאחר המרה
- מעל שעתיים מרגע ההנחה – יש לתת נוזלים לפני ההמרה (בגלל סכנה לכליה)



שלב ה - A

○ הערכה חוזרת של נתיב אוויר וניהול שמרני  או ע"י התערבות 

- תקשורת עם פצוע
- הערכת הכרה (בהכרה/מעורפל/מחוסר או (AVPU
- הפרשות בפה (האם קיים איום על נתיב אוויר?)
- קולות נשימה מהפה (האם קיים איום על נתיב אוויר?)
- שלמות פנים (האם קיים איום על נתיב אוויר?)
- שלמות צוואר (האם קיים איום על נתיב אוויר?)
- החלטה על צורך בשליטה על נתיב אוויר (סדציה ופרה-אוקסיגנציה?)
- החלטה על סיוע נשימתי



שלב ה - R

- העשרה בחמצן 
- בפצוע מונשם חיבור למנשם והכנת תרופות הרדמה להמשך 
- החדרת נקז חזה לפצוע חזה מונשם במידת הצורך בלבד 

● ניטור של פציעות שהתגלו והתערבות ככל שידרש



שלב ה-DE

- הערכת כאב וטיפול **15**
- מניעת זיהומים - שטיפת פצעים, חבישה, טיפול אנטיביוטי **16**
- הערכת GCS, התרשמות מתנועות ידיים ורגליים ובדיקת אישונים **17**
- סריקה גופנית מלאה מהקודקוד ועד לבהונות הרגליים - טיפול בכל פציעה המזוהה בדרך
- קיבוע שברים
- וידוא כלל הקיבועים
- השלמת תיעוד ב-101 דיגיטלי או ידני
- הערכה לקיומה של תגובת דחק/קרב וביצוע התערבות יהל"ם
- העברת דיווח רפואי חוזר

● שינוי: שטיפת פצעים



שלב ה - PFC

- ניטור ותיעוד הסימנים החיוניים באופן תדיר ומחזורי
- החדרת נקז חזה לפצוע חזה נושם עצמונית עם הדרדרות נשימתית  
- מתן חוזר של טיפול תרופתי תוך ורידי  
- הכנסת צנתר שתן ובפצוע מונשם הכנסת זונדה לניקוז הקיבה 
- מניעת פצעי לחץ



דוגמא לביצוע של הסכמה בעבודת צוות

מט"ב

- התרשמות ראשונית מהירה **X**
- עצירת דימום פורץ
- חיפוש מקורות דימום כולל הפיכה **C**
- הערכה קלינית של הפצוע (AVPU, קיום נשימה, טראומה לנתי באוויר, דופק וסטורציה, ל"ד)
- הערכת הלם עמוק והחלטה על מתן מוצרי דם
- הערכת AW ומצב נשימתי
- בחשד לפגיעה - ניהול AW בסיסי **A**
- בהיעדר נשימה - הנשמה באמבו ומסיכה
- שמירה על עמש"צ
- התחלת פינוי במידה זמין - חיתוך מצב ודיווח
- חשיפת ביהח"ז, התרשמות **R**
- הפשטה מלאה כולל איזור מעבר
- ראש - התרשמות מחבלות
- עמש"צ - הנחת צווארון בחשד לפציעה **E**
- הערכת אגן והחלטה על כריכה
- כיסויי ואלונקה
- סיכום הממצאים - הגדרת דחיפות ותכנית טיפול

חובש 1

- דיווח אגמי ודחיפות פינוי **X**
- מדידת ל"ד
- פאלס על האצבע - דופק וסטורציה **C**
- בהיעדר נשימה - הנשמה באמבו ומסיכה
- בהלם עמוק - השגת גישה למחזור הדם ומתן מוצרי דם
- דיווח רפואי (טרם התחלת פינוי)
- חמצן במידת הצורך **R**
- העברת דיווח רפואי עדכני **E**

X הגעה לסביבה מאובטחת

חובש 2

- עצירת דימום פורץ
- חיפוש מקורות דימום כולל הפיכה **C**
- הפשטה מלאה כולל איזורי מעבר
- ביצוע כריכת אגן במידת הצורך
- כיסוי, חימום והעמסה וקיבוע **E**
- על אלונקה
- השלמת תיעוד ב-101





שאלות?